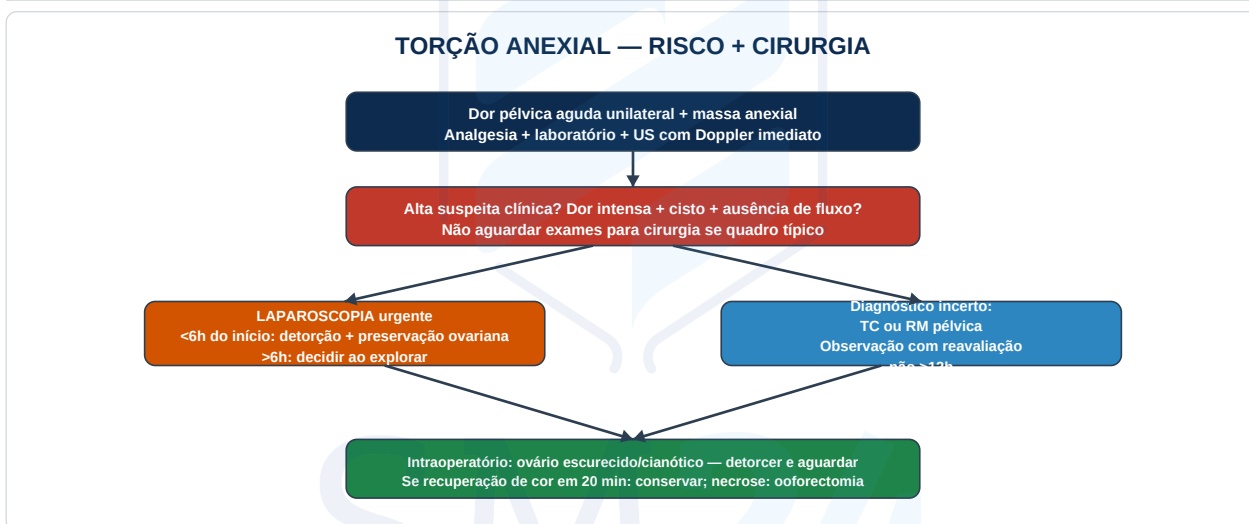


TORÇÃO ANEXIAL — CIRURGIA EM <6H

TORÇÃO ANEXIAL — CLÍNICA E DIAGNÓSTICO

Aspecto	Detalhes
Incidência	2-3% das emergências ginecológicas; mais comum no menacme; gestação: maior risco (corpo lúteo aumentado)
Fisiopatologia	Torção do pedículo vascular (artéria e veia ovarianas) → isquemia → necrose se não tratado em <6-8h
Fatores de risco	Cisto ovariano (>5 cm), ovário policístico, massa anexial, hiperprolifer ovariana por indução de ovulação
Dor	Início agudo, unilateral, em cólica ou contínua, irradiando para flanco/fossa ilíaca; pode ter náusea/vômito
US com Doppler	Ovário aumentado + ausência de fluxo (Doppler), edema do estroma — mas Doppler normal NÃO exclui torção!
TC/RM	Se US inconclusivo; útil em obesas; TC: ovário aumentado + edema; RM: melhor para partes moles

ALGORITMO DE MANEJO



OVÁRIO ESCURECIDO — CONSERVAR OU RETIRAR?

DETORCER PRIMEIRO — DECIDIR DEPOIS

- Ovário cianótico/escurecido: NÃO remover imediatamente — realizar a detorção primeiro
- Após detorção, aguardar 15-20 minutos: se recuperação de cor e turgência = preservar
- Estudos mostram: até 75% dos ovários aparentemente necróticos recuperam função após detorção
- Ooforectomia: apenas se ausência completa de sinais de viabilidade após espera
- Cistoovariectomia pode ser feita no mesmo ato após confirmar viabilidade
- Gestante: mesma conduta — detorção laparoscópica segura no 1o e 2o trimestres

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Diagnóstico	Diferencial chave
Gravidez ectópica	Beta-hCG positivo; US: sem embrião intrauterino; sangue livre na pelve
Apendicite aguda	Dor em FID progressiva, febre, leucocitose; US: apêndice inflamado
Cisto roto	Dor aguda súbita; US: líquido livre; sem massa sólida; resolução espontânea
DIP (inflamação pélvica)	Febre, secreção, dor bilateral, leucocitose; sem massa torcida
Nefrolitíase	Cólica com irradiação para virilha, hematúria; US renal

TORÇÃO NA GESTANTE E SEGUIMENTO

Torção na Gestante

- Mais comum no 1o trimestre (corpo lúteo aumentado) e 2o trimestre
- Sintomas podem ser atribuídos à gestação — atraso diagnóstico
- Laparoscopia segura até ~20 semanas; acima: laparotomia preferida
- Anestesia: considerar aspiração de secreção gástrica, decúbito lateral esquerdo
- Fetal: monitorar batimentos fetais antes e após cirurgia
- Progesterona: repor se <12 semanas e corpo lúteo removido

Prevenção de Recorrência

- Recorrência: 10-15% após detorção sem fixação
- Ooforopexia (fixação do ovário): controversa — reservar para recidiva ou risco muito alto
- Tratar cistos responsáveis: cistectomia no mesmo ato
- Anticoncepcional oral: pode reduzir cistos funcionais recorrentes
- Seguimento US: avaliar viabilidade ovariana em 4-8 semanas
- CA-125: dosagem não diagnóstica na emergência — avaliar após resolução

ABORDAGEM NO PS

FLUXO DA EMERGÊNCIA

- ☐ Analgesia imediata: dipirona + morfina — não retardar diagnóstico por 'máscara de dor'
- ☐ Beta-hCG: SEMPRE em mulher em idade fértil com dor pélvica
- ☐ US transvaginal urgente: ovário contralateral como controle (comparação de tamanho/fluxo)
- ☐ Doppler presente NÃO exclui torção — basear na clínica
- ☐ Contatar ginecologia: não aguardar exames adicionais se alta suspeita
- ☐ Jejum: preparar para cirurgia desde a triagem

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Mulher de 26 anos com dor pélvica direita intensa de início súbito há 4 horas, náuseas e vômitos. US: ovário direito 7 cm, ausência de fluxo ao Doppler. Beta-hCG negativo. Qual é a conduta?

- A) Analgesia e alta com retorno em 24h
- B) TC de abdome antes de qualquer decisão
- C) Laparoscopia urgente com detorção do ovário
- D) Antibiótico IV empírico para DIP
- E) Repetir US em 6h para confirmar o diagnóstico

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Intraoperatoriamente, o ovário torçionado se apresenta escurecido e cianótico. Qual a conduta correta?

- A) Ooforectomia imediata — ovário inviável
- B) Histerectomia de precaução
- C) Detorção do ovário e aguardar 15-20 minutos para avaliar vitalidade
- D) Biópsia e aguardar resultado anatomopatológico
- E) Sutura do pedículo torcido sem detorsão

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

A ausência de fluxo ao Doppler no ovário:

- A) Confirma o diagnóstico de torção e indica cirurgia imediata
- B) Exclui torção — fluxo presente descarta o diagnóstico
- C) Sugere fortemente torção, mas fluxo PRESENTE não exclui torção (Doppler tem falsos negativos)
- D) Indica apenas cistoovariectomia sem necessidade de laparoscopia
- E) É achado normal em ovários de mulheres na pós-menopausa

QUESTÃO 4

SES-DF / Adaptada

Gestante de 10 semanas apresenta dor pélvica esquerda aguda. US: ovário esquerdo 6 cm com cisto e ausência de fluxo. Qual conduta?

- A) Aguardar resolução espontânea — gestação contraindica cirurgia
- B) Laparotomia imediata — laparoscopia é contraindicada na gestação
- C) Laparoscopia urgente — segura no 1o trimestre, mesma conduta que na não gestante
- D) MgSO₄ IV para proteger o ovário
- E) Betametasona + indução do parto

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual é o primeiro exame a ser solicitado para toda mulher em idade fértil com dor pélvica aguda?

- A) US pélvico
- B) Hemograma completo
- C) Beta-hCG sérico ou urinário (excluir gravidez ectópica)
- D) TC de abdome
- E) CA-125

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Torção de ovário: ovário aumentado + ausência de fluxo ao Doppler + dor aguda = indicação de laparoscopia urgente. Cada hora de atraso aumenta o risco de necrose irreversível. Beta-hCG negativo exclui gravidez ectópica. Não aguardar TC.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Ovário escurecido/cianótico: NÃO remover imediatamente. Detorcer e aguardar 15-20 min — recuperação de cor indica viabilidade. Estudos mostram 60-75% dos ovários 'necróticos' recuperam função após detorção. Ooforectomia só se ausência completa de recuperação.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Doppler presente não exclui torção — falsos negativos em até 50% (fluxo arterial pode estar mantido mesmo com isquemia venosa). Diagnóstico de torção é CLÍNICO. Doppler ausente aumenta especificidade mas não é mandatório para indicar cirurgia.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Laparoscopia na gestação: segura no 1o e 2o trimestres (preferência até ~20 semanas). Mesma conduta que na não gestante: detorção + preservação ovariana. Acima de 20-24 semanas: laparotomia preferida (útero volumoso dificulta visualização laparoscópica).

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Beta-hCG é OBRIGATÓRIO em toda mulher em idade fértil com dor pélvica — gravidez ectópica pode mimetizar qualquer causa de dor pélvica aguda e tem risco de ruptura com choque hemorrágico. Beta-hCG negativo permite avançar para outros diagnósticos com mais segurança.

SM24
Suporte ao Plantão Médico